

No	Bupel	No SEP	Grouper	Biaya	Telaah	RAWAT JALAN	RAWAT INAP
1	Jul-23	0187R0130723V002507	I-4-10-III	8.123.600	Kode J81 pada jantung exclude ke kode I50.1		Reseleksi I50.1
2	Jul-23	0187R0130723V005703	G-4-26-II	3.733.600	Diagnosa aphthous stomatitis menggunakan kode K12.0		sudah memakai K12.0
3	Aug-23	0187R0130823V002298	K-1-40-III	11.723.200	Laparotomi, repair hernia omit code		dari pemeriksaan fisik didapatkan defans muskular yang merupakan tanda dari peritonitis, maka perlu dilakukan eksplorasi laparotomi, durante op didapatkan pengotoran cavum abdomen dan abses peritoneum kemudian dilakukan omentectomy, repair hernia dan
4	Aug-23	0187R0130823V010200	I-4-24-I	3.227.100	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I25.2		Reseleksi DU menjadi I50.1 karena pasien datang dengan keluhan sesak, bukan nyeri
5	Aug-23	0187R0130823V009939	I-4-24-II	5.587.200	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I48		Reseleksi DU menjadi I48
6	Aug-23	0187R0130823V010816	I-4-24-II	5.587.200	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I48		Reseleksi DU menjadi I48
7	Aug-23	0187R0130823V004361	I-4-24-I	2.426.400	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I25.1		Reseleksi DU menjadi I501 karena pasien datang dengan keluhan sesak, rhonki +
8	Sep-23	0187R0130823V012552	I-4-10-III	9.464.000	Kode J81 pada jantung exclude ke kode I50.1		ALO pada pasien masih bisa disebabkan oleh penyakit paru, karena pasien sedang mengalami bronkitis kronis eksaserbasi akut, maka ALO non cardiogenic belum
9	Sep-23	0187R0130923V008576	I-4-24-I	2.426.400	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I25.1		Reseleksi DU menjadi I50.1 karena keluhan utama sesak, ronkhi +
10	May-23	0187R0130523V006977	G-4-15-III	5.555.200	Seharusnya DS DM tanpa komplikasi dengan kode E119		Pasien penurunan kesadaran belum dapat disingkirkan penyebabnya apakah karena stroke (karena bacaan stroke normal) atau karena krisis hiperglikeminya
11	Sep-23	0187R0130923V007110	I-4-24-II	7.430.900	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I48		Reseleksi DU menjadi I48
12	Sep-23	0187R0130823V011296	I-4-24-III	7.064.000	Kode J81 pada jantung exclude ke kode I50.1		tidak memakai J81
13	Sep-23	0187R0130923V003482	I-4-24-I	2.426.400	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I25.1		Reseleksi DU menjadi I501 karena pasien datang dengan keluhan sesak, rhonki +
14	Sep-23	0187R0130923V010238	I-4-20-III	5.668.100	Kode J81 pada jantung exclude ke kode I50.1		reseleksi I50.1
15	Sep-23	0187R0130923V007033	I-4-24-I	2.426.400	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I25.1		reseleksi DU I50.1
16	Sep-23	0187R0130923V009382	I-4-20-III	7.538.500	Kode J81 pada jantung exclude ke kode I50.1		reseleksi DU I50.1
17	Sep-23	0187R0130923V009579	I-4-24-III	7.064.000	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I471		Alo pada pasien dapat disebabkan oleh penyakit paru, dimana pada pasien didapatkan ronchi dan wheezing, serta
18	Sep-23	0187R0130823V012197	J-4-21-III	6.486.300	Kode J81 pada jantung exclude ke kode I50.1		ALO pada pasien masih dapat disebabkan oleh faktor non kardiogenik, karena pada pasien terdapat CKD dan PPOK

19	Oct-23	0187R0131023V003850	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0131023V000711	pasien datang mengeluh dengan nyeri dada, dilakukan tindakan thorx dan ecg. Pasien datang kembali pada tgl 9 dengan keluhan yang sama yaitu nyeri dada dan terasa ampeg ketika di buat aktifitas di berikan terapi clopidogrel,isosorbride,simvastatindan bisoprolol	
20	Oct-23	0187R0131023V008926	M-1-50-I	6.091.600	Kode tindakan yang sesuai adalah 86.3		massa dengan dasar otot sehingga menggunakan 83.32
21	Oct-23	0187R0131023V004141	N-2-21-0	4.332.700	Tidak ada indikasi ESWL lebih dari 1x dalam 1 tahun	Dari hasil ctscan didapatkan nefrolithiasis multiple dextra di pole bawah ukuran rata-rata 0,7cm. Karena batu multiple maka dibutuhkan setidaknya 2 kali ESWL. Tidak memungkinkan dilakukan PCNL karena ukuran hanya 0,7cm. Dari IAUI tidak ada konsensus yang menyatakan bahwa ESWL hanya dapat dilakukan 1x	
22	Oct-23	0187R0131023V013092	N-2-21-0	4.332.700	Tidak ada indikasi ESWL lebih dari 1x dalam 1 tahun	Dari hasil ctscan didapatkan nefrolithiasis multiple dextra di pole bawah ukuran rata-rata 0,7cm. Karena batu multiple maka dibutuhkan setidaknya 2 kali ESWL. Tidak memungkinkan dilakukan PCNL karena ukuran hanya 0,7cm. Dari IAUI tidak ada konsensus yang menyatakan bahwa ESWL hanya dapat dilakukan 1x	
23	Oct-23	0187R0131023V007807	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0131023V004791	pasien datang dengan keluhan kaki bengkak saat jalan di sertai dada berdebar dan ngosrong , pasien datang kembali pada tgl 11 oktober pasien datang dengan keluhan kaki semakin bengkak dan tidak bisa untuk aktifitas . Diberikan terapi redroxon.	
24	Oct-23	0187R0131023V005832	I-4-24-II	5.587.200	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I48		reseleksi I48
25	Oct-23	0187R0131023V007453	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0131023V003590	Pasien Kontrol 9/10/23 pasien datang dengan keluhan dada terasa berdebar, pasien mengeluh juga sulit tidur. Pasien datang kembali pada tgl 17 dengan keluhan berdebar masih di rasa, pasien juga mengatakan tidak bisa di buat aktifitas. Di berikan terapi FUROSEMIDE,CLOPIDOGREL,ALLOPURINOL,NITROK AF RETARD FORTE,LANSOPRAZOLE,MINIASPI,ATORVASTATIN,BI SOPROLOL,ANAPRESS	
26	Oct-23	0187R0131023V004155	N-2-21-0	4.332.700	Tidak ada indikasi ESWL lebih dari 1x dalam 1 tahun	Dari hasil ctcan didapatkan batu ren dextra multiple, terbesar ukuran 1cm dengan densitas 820 HU. Karena batu multiple dan densitas 820, dibutuhkan 2x ESWL agar batu dapat hancur sempurna	

27	Oct-23	0187R0131023V013101	N-2-21-0	4.332.700	Tidak ada indikasi ESWL lebih dari 1x dalam 1 tahun	Dari hasil ctcan didapatkan batu ren dextra multiple, terbesar ukuran 1cm dengan densitas 820 HU. Karena batu multiple dan densitas 820, dibutuhkan 2x ESWL agar batu dapat hancur sempurna	
28	Oct-23	0187R0131023V001012	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0130923V011238	pasien mengeluh sesak dan ngosrong saat jalan jauh, pasien datang kembali tgl 3 keluhan masih sama nyeri dada dan sesak di advicekan untuk cek lab di berikan obat allopurinol.	
29	Oct-23	0187R0131023V011395	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0131023V005336	pasien dengan nyeri dada dan sesak , di tgl 26 pasien dengan keluhan nyeri dada semakin sakit di berikan terapi miniaspi.	
30	Oct-23	0187R0131023V010816	I-4-20-III	5.668.100	Kode J81 pada jantung exclude ke kode I50.1		Reseleksi I50.1
31	Oct-23	0187R0131023V006666	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0131023V010847	pasien dengan mengekuk nyeri dada dan ngosrong, pasien datang kembali tgl 25 dengan keluhan pusing dan saat bernafas dada terasa sakit. Di advicekan untuk echocardiography dengan hasil pulmonary hypertension	
32	Oct-23	0187R0131023V001335	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0130923V011634	pasien dengan kedua kaki bengkak, pasien datang kembali pada tgl 4 dengan keluhan kaki semakin bengkak dan tidak bisa untuk berjalan di sertai dengan nyeri dada di advicekan untuk cek lab	
33	Oct-23	0187R0131023V011536	Q-5-44-0	196.100	Fragmentasi dengan No SEP 0187R0131023V008120	pasien datang dengan keluhan pusing dan ngosrong di advicekan untuk treadmill, pasien datang dengan keluhan kaki masih bengkak daqn evaluasi obat .	
34	Oct-23	0187R0130623V011705	I-4-24-III	7.064.000	Seharusnya menggunakan kode DU lebih spesifik yaitu I48		reseleksi I48
35	Oct-23	0187R0131023V002584	Q-5-43-0	277.700	Satu episode dengan No SEP 0187R0131023V002832	pasien datang ke poli jantung menggunakan rujukan dari faskes 1 yang baru di terbitkan 6/10/23 15,51 , dengan keluhan nyeri dada di advicekan untuk cek thorax dengan hasil cardiomegaly dan ecg serta mendapatkan terapi obat dengan diagnosa Atherosclerotic heart disease dan Atrial Fibrillation of Flutter	Pasien masuk IGD datang jam 07,00 dengan keluhan sesak disertai nyeri perut dan di advicekan untuk rawat inap dan pasien dirawat dengan Atrial fibrillation and flutter
36	Mar-23	0187R0130323V009160	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V009493	pasien datang dengan keluhan nyeri perut akibat datang bulan , dan darah tidak bisa berhenti sejak 1 bulan ini .	Pasien datang jam 19,30 dengan perdarahan yang tak kunjung berhenti dilakukan tidnkan dalam rawat inap
37	Feb-23	0187R0130223V009593	Z-3-23-0	578.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130223V009897	pasien mengeluh haid selama 2 minggu tidak bisa berhenti, dan nyeri perut bagian bawah , dilakukan usg untuk di duga pasang iud menyebabkan darah tidak bisa berhenti .	Pasien datang jam 20,20 dilakukan tindakan pada rawat inap
38	May-23	0187R0130523V007471	Q-5-31-0	192.400	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V007518	Menjadi 1 episode perawatan	

39	Jun-23	0187R0130623V006363	Q-5-23-0	145.900	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130623V006679	pasien datang dengan mengatakan nyeri perut di sertai keluar darah terus menerus sejak 3 hari ini , pasien dengan kondisi pregnancy	Pasien datang jam 19,30 dengan perdarahan pasien dirawat dengan blighted Ovum dilakukan tindakan
40	Jun-23	0187R0130623V004885	Q-5-23-0	145.900	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130623V005083	pasien hamil kontrol ke poli obgyn jam 10,11 dengan keluhan dengan kram perut bagian bawah , pasien juga mengatakan kram di rasa terus menerus setiap saat ketika di buat bergerak .	Pasien datang ke IGD jam 16,05 dengan kenceng2 keluar darah dan lendir dari jalan lahir pasien perawatan dengan persalinan
41	Mar-23	0187R0130323V006724	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V006982	pasien datang jam 07,36 mengatakan kaki sebelah kiri ada luka dan berbau di sertai nyeri , pasien evaluasi obat.	Pasien datang jam 19,00 dengan nyeri pada luka kaki kiri dilakukan perawatan tindakan operasi
42	Aug-23	0187R0130823V012281	Q-5-25-0	164.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V012339	pasien datang pukul 18.13 nyeri perut seperti tertutusk2 sejak tadi sore tiba-tiba, nyeri dirasakan menjalar ke dada, mual (-), muntah (-), keringat dingin (+), demam (-), bapil (-), sesak (-), dada ampekan (-), ngongsrong (-)	Pasien datang ke IGD jam 21,55 dengan nyeri dada kiri tembus ke punggung , ke2 tangan terasa kesemutan dan dirawat dengan NSTEMI
43	Aug-23	0187R0130823V008254	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V008736	pasien datang jam 10,25 dengan keluhan benjolan di kaki di sertai nyeri tidak bisa untuk aktifitas, pasien mengatakan aktifitas menjadi terganggu . Kadang pasien tidak bisa berjalan.	Pasien datang jam 19,30 dengan keluhan benjolan di kaki kanan nyeri dan semakin membesar dilakukan perawatan dan tindakan operasi
44	May-23	0187R0130523V009938	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V010228	pasien datang jam 07,48 dengan keluhan benjolan pada payudara disertai nyeri skala 3 hingga merah. Pasien diberikan terapi obat methylprednisolone, cefixime, dan asam tranexamat.	Pasien datang jam 19,36 dengan keluhan nyeri di payu dara kanan dan dirawat dilakukan tindakan operasi
45	May-23	0187R0130523V008725	Z-3-23-0	578.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V009433	pasien datang jam 10,39 dengan nyeri perut kanan bawah tembus hingga pinggang makin lama makin nyeri hingga mengganggu aktifitas dan tidak dapat menjalankan aktifitas seperti berjongkok. Pasien diberikan terapi obat profenalan.	Pasien datang ke IGD jam 20,20 dengan nyeri perut kanan bawah, nyeri hilang timbul pasien dirawat dengan tindakan appendectomy
46	Oct-23	0187R0131023V013008	Z-3-23-0	578.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0131023V013396	pasien datang pukul 09:58 dengan nyeri seluruh lapang perut sejak tadi malam hingga mual muntah, tidak membaik setelah diberikan obat.	Pasien datang ke IGD jam 18,28 dengan nyeri di seluruh lapang perut , lemas, hingga sulit berjalan , nyeri hebat dirasakan di perut bagian bawah pasien dirawat dilakukan tindakan oophorectomy
47	Aug-23	0187R0130823V008251	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V008588	pasien datang jam 10, 28 dengan keluhan batuk disertai dahak selama seminggu tidak bisa berhenti. Pasien mengatakan setiap melakukan aktifitas pasien selalu batuk dan mengganggu aktifitas. Pasien diberikan terapi obat BD FINE PEN NEEDLE, NOVORAPID FLEXPEN, LEVEMIR FLEXPEN, dan PARATUSIN.	Pasien datang ke IGD jam 17,10 dengan badan lemas, demam menggigil, mmual, nyeri perut ulu hati , perih dirawat dengan DM
48	Aug-23	0187R0130823V006502	Q-5-42-0	198.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V006864	pasien datang pukul 03:01 demam sejak hari ini, batuk (+) kering, pilek (-), sesak (-), nyeri perut (-), nyeri tenggorokan (-)	Pasien datang ke IGD jam 16,30 dengan demam menggigil , sudah minum obat blm ada perbaikan dirawat dengan susp.

49	Jul-23	0187R0130723V008145	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130723V008235	(BERKAS TIDAK ADA DIBILLING)	Pasien datang ke IGD jam 13,15 dengan mual, muntah tidak membaik dengan obat , nyeri ulu hati, lemas , tangan dan kaki dingin , BAK sedikit dirawat dengan CKD
50	Mar-23	0187R0130323V004304	Q-5-23-0	145.900	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V004634	pasien jam 08,02 mengeluh perut kenceng-kenceng dirasa terus menerus setiap saat ketika melakukan aktifitas maupun tidak melakukan aktifitas. Pasien dengan kondisi pregnancy. Pasien diberikan terapi obat NEUROMED dan EMINETON.	Pasien datang ke IGD jam 15,45 dengan keluhan kencing2 keluar lendir dan darah pasien perawatan dengan persalinan
51	Mar-23	0187R0130323V004624	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V004804	pasien datang 15,52 dengan keluhan mata kabur, semakin lama terasa kemeng hingga berair. Pasien mengatakan sulit untuk melakukan aktifitas. Pasien mendapatkan terapi obat GLAUSETA dan CENDO XITROL.	Pasien datang ke IGD jam 21,10dengan keluhan lemas , mual, muntah, pusing, nyeri ulu hati dirawat dengan DM+dyspepsia
52	Mar-23	0187R0130323V005030	Q-5-25-0	164.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V005278	pasien 13,11 dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah hingga menembus ke pinggang saat melakukan aktifitas terganggu. Semakin lama semakin nyeri ketika bergerak.	Pasien datang jam 17,50 dengan nyeri perut sebelah kanan, mual dan muntah perawatan di rumah sakit dan tindakan operasi
53	Mar-23	0187R0130323V000782	Q-5-23-0	145.900	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V001085	pasien 07,39 datang dengan keluhan perut kenceng-kenceng, pasien juga mengatakan kencing-kencing di rasa terus menerus setiap saat ketika di buat bergerak maupun tidak.	Pasien datang jam 21,00 dengan persalinan
54	Jun-23	0187R0130623V008393	Z-3-27-0	201.000	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130623V008438	Menjadi 1 episode perawatan	
55	Mar-23	0187R0130323V010708	Z-3-23-0	578.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V011013	pasien 08,42 datang dengan keluhan nyeri perut di sertai keluar darah terus menerus tidak berhenti selama 3 bulan. Pasien diadvicikan untuk tindakan USG.	Pasien datang jam 19,30 dengan menometoragi
56	Aug-23	0187R0130823V009943	Z-3-23-0	578.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V010199	pasien jam 10,30 mengatakan nyeri pada perut bagian atas hingga bawah, semakin lama semakin nyeri sehingga sulit untuk melakukan aktifitas. Dokter mengadvicikan untuk USG abdomen dengan hasil appeccindicitis akut.	Pasien datang ke IGD jam 17,45 dengan keluhan nyeri perut kanan bawah , demam, mual , muntah pasien perawatan dengan tindakan Appendectomy
57	May-23	0187R0130523V003615	Q-5-23-0	145.900	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V003858	Pasien jam 07,09 pasien dengan kram perut bagian bawah , pasien juga mengatakan kram di rasa terus menerus setiap saat ketika di buat bergerak .	Pasien datang jam 14,35 dengan keluar darah dari jalan lahir dan kencing - kencing pasien MRS dengan Persalinan
58	Jul-23	0187R0130723V010051	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130723V010342	pasien jam 14,40 mengeluhkan kepala terasa pusing terus menerus disertai pilek dan batuk tidak berhenti hingga mengganggu aktifitas. Pasien juga mengeluhkan sulit untuk tidur. Pasien diberikan terapi obat TREMENZA, LEVOFLOXACIN, dan METHYLPREDNISOLONE.	Pasien datang ke IGD jam 19,55 dengan demam, BAB darah ,diserati muntah sudah >6X , nyeri ulu hati, mual, muntah, lemas dirawat dengan dyspepsia dan Hypokalemia
59	Mar-23	0187R0130323V011650	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V011810	pasien kontrol ke poli obgyn jam 13,08 datang dengan keluhan nyeri perut di sertai keluar darah terus menerus, pasien dengan kondisi pregnancy .	Pasien datang jam 19,30 dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir dilakukan perawatan rawat inap dengan tindakan curretage

60	Jun-23	0187R0130623V005569	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130623V005672	Menjadi 1 episode perawatan	
61	Jul-23	0187R0130723V002480	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130723V002503	pasien ke poli mata jam 18,02 datang dengan mengatakan mata merah dan berair disertai nyeri seperti terbakar ketika mata melakukan aktifitas sehingga pasien tidak dapat melakukan aktifitas. Pasien diberikan terapi obat CENDO PROTAGENTA.	Pasien dengan jam 20,24 dengan kencing kencing pasien dirawat inap dengan persalinan DPJP dan keluhan berbeda dengan kunjungan Poli rawat jalan sebelumnya
62	Aug-23	0187R0130823V009829	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V010169	pasien kontrol ke poli anak jam 06,43 dengan demam naik turun suhu 38 derajat disertai batuk pilek sejak 3 hari ini. Sudah diberi obat tapi keluhan masih dirasa. Pasien diberikan terapi obat ERDOSTEIN, CEFIXIME, dan PARACETAMOL.	Pasien datang ke IGD jam 17,05 dengan demam sudah 3 hari tidak membaik dengan obat penurun panas dan semakin tinggi panasnya, batuk, pilek demam suhu 39,9 pasien dirawat inap dengan diagnosa
63	Jul-23	0187R0130723V002086	Q-5-25-0	164.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130723V002403	pasien datang pukul 07:17 pasien datang dengan keluhan nyeri perut sejak kemarin disertai mual muntah (+), diare (-), demam (-), batuk pilek (-)	Pasien datang ke IGD jam 16,15 dengan keluhan nyeri perut sejak hari minggu malam. Awalnya di ulu hati namun memberat ke seluruh area perut pasien diagnosa Calculus of gallbladder with other
64	May-23	0187R0130523V000751	Q-5-23-0	145.900	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V001186	pasien kontrol ke poli obgyn jam 07,29 dengan kram perut bagian bawah , pasien juga mengatakan kram di rasa terus menerus setiap saat ketika di buat bergerak .	Pasien datang jam 19,30 dengan keluhan kencing - kencing pasien rawat inap persalinan dilakukan tindakan SC
65	Aug-23	0187R0130823V008707	Q-5-25-0	164.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V008744	pasien datang ke poli IPD jam 18,30 mengeluh perut kembung disertai mual dan muntah hingga tidak dapat buang angin diadvicekan untuk foto BNO dengan hasil ilius obstruktif.	Pasien datang ke IGD jam 22,10 dengan keluhan tidak bisa flatul sejak 2 hari, mual, muntah tiap makan , perut nyeri pasien dirawat dengan diagnosa paralytic ileus
66	May-23	0187R0130523V010542	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V010653	pasien datang jam 09,58 dengan keluhan nyeri perut akibat datang bulan , dan darah tidak bisa berhenti selama 3 bulan.	Pasien datang jam 19,30 dengan keluar dari jalan lahir dengan diagnosa menometoragi
67	Aug-23	0187R0130823V007585	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V007845	pasien datang ke poli kulit jam 06,58 dengan keluhan gatal seluruh tubuh hingga kulit bersisik, menebal, dan mudah terkelupas hingga mengganggu aktifitas. Pasien diberikan terapi obat KLODERMA OINTMENT, SALICYLIC ACID, CETIRIZINE, GENTAMICIN SALEP 0,1%, dan VASELIN ALBUM.	Pasien datang ke IGD jam 19,45 dengan keluhan bengkak ke seluruh tubuh, awalnya kedua kaki saja kemudian ke paha dan perut, dikemaluan juga, ngongsrong saat aktivitas sehari", pasien rawat inap dengan ADHF, DM tipe 2 dan sirosis,
68	Oct-23	0187R0131023V007853	Z-3-23-0	578.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0131023V008022	pasien datang ke Poli Bedah jam 15,45 dengan nyeri perut kanan bawah tembus hingga pinggang makin lama makin terasa nyeri. Pasien diadvicekan tindakan usg abdomen dengan hasil appendicitis akut.	Pasien datang ke IGD jam 19,30 dengan keluhan nyeri perut hilang timbul, makin nyeri dan menetap, demam, mual pasien rawat inap dengan tindakan Apendectomy
69	Apr-23	0187R0130423V005170	M-3-16-0	134.300	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130423V005457	Pasien diberikan terapi IFT jam 07,48 pasien datang dengan keluhan nyeri pada bagian punggung bawah semakin lama semakin nyeri. Pasien juga mengeluhkan sulit beraktifitas hingga sulit untuk tidur.	Pasien datang ke IGD jam 20,35 dengan keluhan nyeri perut memberat, demam, mual, muntah, pusing, nyeri memberat saat makan pedas dirawta dengan Abdominal pain, DPJP dan keluhan berbeda dengan kunjungan Poli rawat

70	Apr-23	0187R0130423V000313	Z-3-23-0	578.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130423V000371	pasien datang jam 10,40 ke poli Obgyn baru mendapatkan rujukan dari Faskes 1 baru pertama kali dengan mengatakan nyeri perut di sertai keluar darah terus menerus selamat 3 bulan, pasien diadvicekan untuk USG.	Pasien datang dengan keluar dari jalan lahir dengan diagnosa menometoragi
71	May-23	0187R0130523V000663	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V000701	pasien datang jam 18,00 ke poli kulit dengan keluhan gatal disertai kemerahan seluruh kepala hingga kulit mengelupas. Pasien diberikan terapi obat KLODERMA OINTMENT, VASELIN ALBUM, METHYLPREDNISOLONE TAB, GENTAMICIN SALEP, dan CETIRIZINE.	Pasien datang di IGD jam 23,20 dengan sesak sejam malam , disertai nyeri seluruh dada terasa cekot2 dan badan terasa lemas dan pasien di rawat dengan STEMI, ALO dan DM dan pasien mrninggal 3/5/23 jam 14,15, DPJP dan keluhan berbeda dengan kunjungan Poli rawat jalan
72	Mar-23	0187R0130323V009388	Q-5-23-0	145.900	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V009498	Menjadi 1 episode perawatan	
73	Mar-23	0187R0130323V011004	Q-5-25-0	164.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V009541	Pasien Post KRS dari Rawat inap jam 07,00 dan berkunjung ke IGD jam 20,06 pasien lemas dengan tidak mau makan post KRS, setiap makan / minum muntah dan sudah minum obat dari dokter SPA masih muntah di IGD diberi terapi injeksi dan membaik lalu pulang.	Pasien KRS 29/3/23 jam 07,00 post MRS tgl 26/3/23 dengan demam suhu 39,4 - 41 , menggigil, sulit tidur dan nafsu makan menurun dirawat inap dengan diagnosa TF
74	Aug-23	0187R0130823V002382	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V002516	pasien datang dengan membawa rujukan baru ke poli syaraf jam 09,56 mengeluh tidak enak dan nyeri pada seluruh kepala makin lama makin nyeri sehingga mengganggu aktifitas mulai dari bangun tidur. Pasien diadvicekan untuk dilakukan lab dan diberikan terapi dengan diagnosa Cluster headache syndrome	Pasien datang ke IGD jam 13,00 dengan demam naik turun, nyeri kepala, mual, muntah, nyeri perut ulu hati, batuk kering suhu 38,2 dirawat inap dengan diagnosa TF keluhan berbeda dengan kunjungan Poli rawat jalan
75	Mar-23	0187R0130323V008235	Q-5-42-0	198.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130323V008248	pasien datang pukul 19:34 pasien datang dengan keluhan demam sejak 4 hari yang lalu, demam dikeluhkan mengigil, mual muntah lebih 10 hari ini, badan terasa sakit semua, badan lemas .	Pasien datang ke IGD jam 21,35 dengan demam menggigil, mual, diare >10X suhu 38 pasien rawat inap dengan duagnosa DF
76	May-23	0187R0130523V000476	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V000698	pasien datang jam 15,44 dengan keluhan mata merah seperti terbakar dan gatal disertai nyeri ketika digunakan beraktifitas. Pasien diberikan terapi obat CENDO CATARLENT dan NUVISION.	Pasien datang ke IGD jam 20,00 dengan keluhan nyeri tak tertahankan pada telinga dan kepala kanan hingga leher, pusing, mual, muntah >3X, lemas pasien dirawat dengan Zoster without complication dan HDD. DPJP dan keluhan berbeda dengan
77	Jun-23	0187R0130623V005750	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130623V005766	pasien berkunjung jam 17,39 mengeluh kesulitan ketika buang air kecil hingga terasa nyeri sudah semingguan, sudah diberi obat tapi keluhan masih dirasa. Pasien dilakukan tindakan pemasangan foley cath.	Pasien IGD jam 19.00 dengan keluhan pasien tidak bsa BAK diadvicekan operasi dilakukan tindakan Unilateral orchiectomy
78	May-23	0187R0130523V002702	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130523V002935	Pasien berkunjung jam 15.24 dengan rujukan baru yang baru terbit dari faskes 1 ke poli urologi prima husada dengan diagnosis Scrotal varises	pasien datang ke IGD pk 19.45 dengan keluhan nyeri testis membesar sebelah kiri, nyeri apabila ditekan dan advice rawat inap dilakukan tindakan orchidectomy dan

79	Jul-23	0187R0130723V011259	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130723V011640	Menjadi 1 episode perawatan	
80	Jul-23	0187R0130723V001682	Q-5-25-0	164.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130723V001872	Pasien datang ke IGD pk.08.33 dengan keluhan mual dan muntah sejak tadi pagi . Mual muntah sebanyak 8 kali dengan diagnosa vomiting profuse diberikan terapi obat dan pasien advice pulang.	Pasien datang ke IGD jam 15.00 dengan keluhan demam dan sudah d berikan obat tetapi tidak membaik, pasien mual muntah >9X hari ini , batuk dan pilek suhu 37,8 dan di foto thorax bronchopneumonia dan
81	Aug-23	0187R0130823V006626	Q-5-44-0	196.100	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130823V006678	Pasien kontrol rawat jalan poli anak 16/8/23 pk 09,54 dengan diagnosa nenontal jaundice dan diberikan terapi,	Pada pukul 12,50 ibu pasien berkunjung ke IGD dengan kuning seluruh tubuh dan suhu 39,3 dan diadvicekan rawat inap dengan neonatal jaundice
82	Sep-23	0187R0130923V012410	Q-5-42-0	198.700	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0130923V012574	Pasien berkunjung jam 16.19 dengan rujukan baru yang baru terbit dari faskes 1 ke poli anak prima husada dengan pemfis: Bayi umur 7 hari kuning dan mat kuning dengan diagnosa Neonatal Jaundice serta diberi terapi obat.	
83	Nov-23	0187R0131123V009428	A-4-12-I	3.170.200	Satu episode dengan No SEP RITL 0187R0131123V008415		Pasien BBL datang ke IGD pukul 22.10 dengan badan lemas, bayi lebih rewel dari biasanya, BAB sering serta penurunan BB , Bayi kuning, nafsu makan menurun RR 40 x/menit dan diadvicekan rawat inap